Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Lajeado

Rua Paulo Frederico Schumacher, 77 - Bairro: Moinhos - CEP: 95900780 - Fone: (51) 3710-1500 - Email: frlajeado2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5014925-34.2022.8.21.0017/RS

AUTOR: FRANCIELE ALINE DE ANDRADE

RÉU: UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.

SENTENÇA

Vistos.

FRANCIELE ALINE DE ANDRADE ajuizou *ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar de antecipação de tutela* para fornecimento de medicamentos contra **UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.**. Narrou que está com 34 semanas de gestação e, após diversos exames e consulta com especialistas, recebeu o diagnóstico de Trombofilia - alteração alfa metil redutase - CID 10 O 99.4, 7 87.5 e 026.2. Pontuou que a patologia que a acomete pode ocasionar a interrupção da gestação, assim como risco de morte à parturiente. Para o tratamento, a recomendação médica foi para o uso do medicamento enoxaparina 40mg, 2 ampolas a serem ministradas de 12 em 12 horas, durante todo o período gestacional e pós parto. Pediu, em tutela provisória de urgência, que a ré forneça o medicamento indicado pelo médico. Ao final, requereu a confirmação da tutela provisória e a procedência dos pedidos, para condenar a ré na obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento até o final da gravidez e durante o puerpério. Requereu a concessão da gratuidade judiciária. Atribuiu à causa o valor de R$10.325,52. Juntou documentos.

Foi concedido o benefício da justiça gratuita e deferida a tutela provisória de urgência (**Despacho/decisão 1**).

Citada, a ré contestou (**Contestação 1**). Pontuou o caráter domiciliar do fármaco postulado. Disse que, não se tratando de antineoplástico, a oferta de medicamento domiciliar está expressamente excluída do contrato, o que mencionou estar referendado pelo art. 10, inciso VI, da Lei n.º 9.656/98, não sendo ponto excepcionado pelo art. 12 da mencionada lei. Discorreu sobre a legislação aplicável. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos formulados. Juntou documentos.

Houve réplica (**Réplica 1**).

A requerida interpôs agravo de instrumento, havendo o deferimento do efeito suspensivo e, posteriormente, o provimento.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Decido.

Fundamentação.

O processo tramitou regularmente, com a observância de todas as formalidades legais, estando isento de vícios ou irregularidades.

Cabível o julgamento antecipado do mérito, em razão da matéria discutida, não sendo necessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Inexistindo preliminares a serem examinadas, passo à análise do mérito.

De início, observo que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na interpretação do contrato deverá ser observado o disposto no art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Súmula 608-STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Sobre o tema, cabe evidenciar a divergência a respeito do caráter do rol de procedimentos publicado pela ANS, se exemplificativo ou taxativo.

Em 08.06.2022, a 2ª Seção do STJ decidiu que o rol é, em regra, taxativo:

1 - O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:

(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da Saúde Suplementar;

(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

STJ. 2ª Seção.EREsp 1.886.929-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022 (Info 740).

Contudo, em notória reação legislativa (chamado efeito *backlash*), adveio a Lei n.º 14.454/2022 alterou o art. 10 da Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98), incluindo o §12, que prevê o caráter exemplificativo do rol da ANS:

Art. 10. (...)

§12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

A Lei n.º 14.454/2022 entrou em vigor no dia 22.09.2022.

Ademais, não se pode descurar do disposto no art. 4º, inciso III, da Lei 9.661/00, normativa que criou Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS:

Art. 4º Compete à ANS:

*III - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, **que constituirão referência básica** para os fins do disposto na Lei n.º 9.656/98, e suas excepcionalidades;*

Assim, diante da legitimidade democrática que se reveste a produção legislativa e considerando que decisão do STJ é desprovida de caráter vinculante, posiciono-me no sentido de que o rol de procedimentos publicado pela ANS constitui apenas uma referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde.

Desta forma, o fato de o procedimento médico que se pretende obter cobertura não constar no rol da ANS, por si só, não excetua sua cobertura.

Nesse sentido, aponto precedentes do Tribunal de Justiça do Estado:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. FORNECIMENTO DO FÁRMACO BELIMUMABE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO ANTINEOPLÁSICO. ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98. AUSENTE PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. 1. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, §2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998. 2. **AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI.** NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10. 3. **NO PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE PUBLICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR É TÃO SOMENTE REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NÃO POSSUINDO CARÁTER TAXATIVO, O QUE FOI RATIFICADO PELA INCLUSÃO DO § 12 NO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 PELA LEI Nº 14.454/2022**. (...). 7. DE CONSEQUÊNCIA, COM FULCRO NO §11 DO ARTIGO 85 DO CPC, RESTAM MAJORADOS OS HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE AUTORA AOS PROCURADORES DA PARTE RÉ APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50034053920218210041, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-06-2023).

Inclusive, com lastro no entendimento de que o plano de saúde não pode se recusar a custear fármaco prescrito pelo médico, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado, assim como que o que importa é a existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado, foi concedida a tutela provisória de urgência, em 26.12.2022, com respaldo de precedente da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, cujo julgamento ocorreu em 14.12.2022.

A saber:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. **PLANO DE SAÚDE. TROMBOFILIA. MEDICAMENTO ENOXAPARINA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO.** DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. NO CASO EM TELA, **A AUTORA APRESENTA DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA, O QUAL PODE OCASIONAR COMPLICAÇÕES OBSTÉTRICAS, MORTE FETAL E TAMBÉM TROMBOSE MATERNA, SENDO NECESSÁRIO REALIZAR O TRATAMENTO COM A MEDICAÇÃO *ENOXOPARINA* SÓDICA ATÉ, PELO MENOS, 28 DIAS APÓS A GESTAÇÃO/PARTO.** A COBERTURA PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO FOI NEGADA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE É DE USO DOMICILIAR. II. ENTRETANTO, OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NA FORMA DA SÚMULA 608, DO STJ, DEVENDO SER INTERPRETADOS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL À PARTE MAIS FRACA NESTA RELAÇÃO. DE OUTRO LADO, OS PLANOS DE SAÚDE APENAS PODEM ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA, NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE, AINDA QUE NÃO HAJA PREVISÃO EM ROL DA ANS, O QUAL CONSTITUI APENAS REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURA, CONFORME § 12 DO ART. 10 DA LEI N° 9.656/98, INCLUÍDO PELA LEI N° 14.454/2022, NÃO SENDO, PORTANTO, TAXATIVO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51, IV, § 1°, II, DO CDC. III. ADEMAIS, DE ACORDO COM O § 13, I, DO ART. 10 DA LEI N° 9.656/98, INCLUÍDO PELA LEI N° 14.454/2022, É POSSÍVEL COBERTURA DE PROCEDIMENTO OU TRATAMENTO QUE NÃO ESTEJA PREVISTO NO ROL DA ANS QUANDO EXISTIR COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA, À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE, BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E PLANO TERAPÊUTICO OU EXISTAM RECOMENDAÇÕES PELA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (CONITEC), OU EXISTA RECOMENDAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1 (UM) ÓRGÃO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE QUE TENHA RENOME INTERNACIONAL, DESDE QUE SEJAM APROVADAS TAMBÉM PARA SEUS NACIONAIS. NO CASO EM TELA, VERIFICA-SE QUE HÁ RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM RELAÇÃO AO FÁRMACO EM QUESTÃO. IV. **QUANTO AO USO DOMICILIAR DO REMÉDIO, NÃO HÁ OBRIGAÇÃO DO SEU FORNECIMENTO PELAS OPERADORAS, AFORA AQUELES DETERMINADOS PELA LEI, MAS NÃO EM QUALQUER CASO. ASSIM, EM CASOS DE RISCO DE VIDA, COMO INDICADO PELA MÉDICO-ASSISTENTE NA PRESENTE LIDE, O LOCAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO É IRRELEVANTE PARA DEFINIR O DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. EM OUTRAS PALAVRAS, SE HÁ COBERTURA PARA A DOENÇA, DEVE SER FORNECIDO O MEDICAMENTO MINISTRADO PELO MÉDICO, MESMO QUE PARA USO DOMICILIAR.** V. PORTANTO, À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI N° 9.656/98, IMPÕE-SE À OPERADORA DO PLANO SUPORTAR AS DESPESAS DO TRATAMENTO EM QUESTÃO. [...] APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50104340320218210022, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 14-12-2022).

Não obstante, cabe assinalar que a matéria em exame passou por modificação de entendimento pela própria Câmara acima referida, tendo a Des. Rel. LUSMARY FATIMA TURELLY DA SILVA consignado, em seu voto, no julgamento da apelação cível nº 5003405-39.2021.8.21.0041/RS, desprovida por unanimidade, o seguinte trecho:

"*Dito isso e considerando a recente jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita, que considera legítima a recusa de cobertura pelas operadoras de plano de saúde de medicamentos de uso domiciliar que não sejam antineoplásicos ou de uso em regime de home care,* ***destaco que revi o meu posicionamento anteriormente exarado acerca da matéria***."

Ementa do acórdão mencionado:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. FORNECIMENTO DO FÁRMACO BELIMUMABE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO ANTINEOPLÁSICO. ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98. AUSENTE PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. 1. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, §2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998. 2. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10. 3. NO PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE PUBLICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR É TÃO SOMENTE REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NÃO POSSUINDO CARÁTER TAXATIVO, O QUE FOI RATIFICADO PELA INCLUSÃO DO § 12 NO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 PELA LEI Nº 14.454/2022. 4. **NÃO OBSTANTE O CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DA ANS, SALIENTA-SE QUE O ART. 10 DA LEI 9.656/98 APRESENTA HIPÓTESES EXPRESSAS EM QUE SE POSSIBILITA A EXCLUSÃO DE COBERTURA PELAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE, DENTRE AS QUAIS ESTÁ INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, À**

EXCEÇÃO DOS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E MEDICAÇÕES EM REGIME DE HOME CARE. 5. NESSE CONTEXTO E CONSIDERANDO A RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA MATÉRIA, AS OPERADORAS DE SAÚDE, SALVO CONTRATAÇÃO QUE AMPLIE O ÂMBITO DE COBERTURA, NÃO DETÊM OBRIGAÇÃO DE COBRIR MEDICAMENTOS QUANDO EM USO DOMICILIAR, EXCETUADOS OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E MEDICAÇÕES EM REGIME DE HOME CARE - HIPÓTESES DISTINTAS DA QUE SE OBSERVA NO PRESENTE FEITO. 6. DITO ISSO, NÃO HÁ FALAR EM DEVER DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE DO MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR PLEITEADO, AFIGURANDO-SE LEGÍTIMA A RECUSA DE FORNECIMENTO. 7. DE CONSEQUÊNCIA, COM FULCRO NO §11 DO ARTIGO 85 DO CPC, RESTAM MAJORADOS OS HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE AUTORA AOS PROCURADORES DA PARTE RÉ APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50034053920218210041, **Quinta Câmara Cível**, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: **28-06-2023**).

Com a alteração de posicionamento, passou a ser entendido que, não obstante o caráter exemplificativo do rol da ANS, **o art. 10 da Lei 9.656/98 apresenta hipóteses expressas em que se possibilita a exclusão de cobertura pelas operadoras de plano de saúde, dentre as quais está incluído o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar**, à exceção dos antineoplásicos orais e medicações em regime de *home care*.

É a previsão legal:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

II - quando incluir internação hospitalar:

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

Com base nisso, formou-se entendimento de que **é considerada legítima a recusa de cobertura pelas operadoras de plano de saúde de medicamentos de uso domiciliar que não sejam antineoplásicos ou de uso em regime de *home care***.

Portanto, pela compreensão atual, as operadoras de saúde, salvo contratação que amplie o âmbito de cobertura, não detêm obrigação de cobrir medicamentos quando em uso domiciliar, à exceção dos antineoplásicos orais e medicações em regime de *home care* - hipóteses distintas da que se observa no presente feito.

A respeito do tema, há precedente decidindo pela admissão de recurso especial que enfrenta a matéria:

RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE TROMBOFILIA GESTACIONAL. ENOXAPARINA (CLEXANE). AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NA COBERTURA DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. RAZÕES RECURSAIS QUE ENCONTRAM GUARIDA NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. RECURSO ADMITIDO. (Apelação Cível, Nº 50066174320218210017, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 05-06-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE TROMBOFILIA GESTACIONAL. MEDICAMENTO DENOMINADO ENOXAPARINA. COBERTURA INDEVIDA. RETORNO DO STJ. NOVO JULGAMENTO. 1. OS PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RAZÃO PELA QUAL SE APLICA O DISPOSTO NO ART. 35 DA LEI 9.656/98 AO CASO EM TELA, DECORRENTE DE INTERPRETAÇÃO LITERAL E MAIS BENÉFICA AOS ADERENTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ. 2. **NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ, NÃO SE AFIGURA ILÍCITA A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR, SALVO OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS (E CORRELACIONADOS), A MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) E OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM**. 3. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA EXCLUSÃO CONTRATUAL E LEGAL.

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50000826920198210114, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-03-2023).

Destarte, embora a concessão da tutela provisória de urgência, o exame do mérito requerer um estudo aprofundado e em atenção ao conjunto normativo incidente, assim como ao posicionamento jurisprudencial, o qual passo a observar para o exame em cognição exauriente.

Veja-se, parte autora postulou a cobertura pela ré do medicamento enoxaparina de 40mg (**Petição Inicial 1** , **Atestado Médico 6** e **Atestado Médico 8**), o qual consiste em fármaco de uso domiciliar - que não se enquadra nas exceções legalmente previstas (antineoplásico ou de uso em regime de *home care*).

Outrossim, o contrato expressamente dispõe sobre a exclusão de fornecimento de medicamento fora do regime de internação hospitalar e qualquer serviço ambulatorial exclusivo para aplicação de medicamento que pode ser realizado no domicílio (**Contrato 2**):

VI. EXCLUSÕES DE COBERTURA

Cláusula 11: Estão expressamente excluídos de cobertura, sobre eles não assumindo a CONTRATADA qualquer responsabilidade, os seguintes fornecimentos:

XIV. fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, assim entendidos aqueles que prescritos pelo médico assistente/cooperado sem indicação de que sejam ministrados em ambiente externo ao da unidade de saúde;

Com efeito, ante a ausência de previsão contratual para a cobertura de medicações de uso domiciliar (pelo contrário, tem-se a expressa exclusão do fornecimento pretendido), que encontra respaldo legal de exclusão de cobertura (art. 10, incisos V e VI, da Lei 9.656/98), não há falar em dever de fornecimento pela operadora do plano de saúde, afigurando-se legítima a recusa pela ré.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. FORNECIMENTO DO FÁRMACO BELIMUMABE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO ANTINEOPLÁSICO. ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98. AUSENTE PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. (...) 5. **NESSE CONTEXTO E CONSIDERANDO A RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA MATÉRIA, AS OPERADORAS DE SAÚDE, SALVO CONTRATAÇÃO QUE AMPLIE O ÂMBITO DE COBERTURA, <u>NÃO DETÊM OBRIGAÇÃO DE COBRIR MEDICAMENTOS QUANDO EM USO DOMICILIAR, EXCETUADOS OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E MEDICAÇÕES EM REGIME DE HOME CARE - HIPÓTESES DISTINTAS DA QUE SE OBSERVA NO PRESENTE FEITO</u>. 6. DITO ISSO, NÃO HÁ FALAR EM DEVER DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE DO MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR PLEITEADO, AFIGURANDO-SE LEGÍTIMA A RECUSA DE FORNECIMENTO**. 7. DE CONSEQUÊNCIA, COM FULCRO NO §11 DO ARTIGO 85 DO CPC, RESTAM MAJORADOS OS HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE AUTORA AOS PROCURADORES DA PARTE RÉ APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50034053920218210041, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-06-2023).

Não obstante, cumpre consignar que, em grau recursal, a Desembargadora CLAUDIA MARIA HARDT, em seu voto, entendeu por reformar a decisão liminar concedida, dando provimento ao agravo de instrumento da parte requerida, inclusive liminarmente suspendendo a eficácia da decisão agravada, sem qualquer manifestação da parte autora no decorrer do processamento recursal.

Destarte, diante da análise realizada em cognição exauriente e em atenção ao recente posicionamento jurisprudencial sobre o tema, **<u>REVOGO</u> a tutela provisória de urgência concedida**, impondo-se a improcedência dos pedidos.

Dispositivo.

Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC, <u>REVOGO</u> a tutela provisória de urgência e julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por **FRANCIELE ALINE DE ANDRADE** contra **UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.**

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono da parte adversa, segundo os vetores do artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho dos profissionais e o julgamento antecipado da lide. Resta suspensa a exigibilidade da sucumbência em face da parte autora, face a AJG deferida, na forma do artigo 98, § 3°, do CPC.

Havendo interposição de recurso, à parte adversa para contrarrazões, no prazo legal, e na sequência, remetam-se os autos ao TJRS.

Após, com o trânsito em julgado e em nada mais sendo requerido, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **JOAO GILBERTO MARRONI VITOLA, Pretor**, em 4/10/2023, às 16:18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10047143619v24** e o código CRC **243bbdf0**.